

·不合理处方分析·

降糖药的药物相互作用(2)

张 芳 王少华

266011 青岛市市立医院药剂科

处方 4 格列吡嗪与肝素钠

格列吡嗪 5mg×60 5mg qd po
0.9%氯化钠 250ml
肝素钠 12500u ivdrop st

分析:一糖尿病患者服用格列吡嗪治疗 6 个月,病情稳定,后因心肌梗死入院治疗,静脉输注肝素钠,2 日后患者发生低血糖反应。两药合用时,肝素可激活脂蛋白脂酶,增加脂肪的水解,使游离脂肪酸浓度升高,从而置换与血浆蛋白结合的格列吡嗪,使后者游离血药浓度升高,降糖作用增强,引起低血糖。根据相互影响的机制推测,肝素与其他磺酰脲类降糖药(甲苯磺丁脲、格列本脲、氯磺丙脲等)也可发生类似相互影响。

处理方法:应避免两药同用。如确需合用,应按血糖水平,减低格列吡嗪的用量。

处方 5 优降糖与氟康唑

优降糖 2.5mg×100 2.5mg bid po
氟康唑 50mg×20 200mg qd po

分析:本方为一糖尿病患者在用优降糖治疗期间,因患体癣用氟康唑治疗时,患者出现低血糖。两药合用氟康唑可抑制优降糖的代谢,使之降糖作用与毒性均增强。根据相互影响的机制推测,其他磺酰脲类口服降糖药(如醋磺丙脲、氯磺丙脲、甲苯磺丁脲等)与其他咪唑类抗真菌药(如酮康唑、咪康唑、伊曲康唑等),也可发生类似相互影响。

处理方法:在用优降糖治疗期间,如果需要应用氟康唑,可根据血糖水平减少优降糖的剂量。同用期间,应经常测定血糖浓度,如优降糖不能满意控制血糖水平,应短期换用胰岛素。

处方 6 格列齐特与雷尼替丁

格列齐特 80mg×60 80mg bid po
雷尼替丁 0.15g×30 0.15g bid po

分析:两药合用由于雷尼替丁抑制格列齐特在肝脏的代谢,使后者降糖作用增强,有引起严重低血糖的危险。研究表明,雷尼替丁与格列吡嗪、格列本脲之间也可发生类似相互作用。

处理方法:糖尿病患者最好避免同时应用雷尼替丁(或西咪替丁)和磺酰脲类降糖药。如确需合用,应特别警惕在开始合用及停用雷尼替丁(或西咪替丁)后可能发生的低血糖或高血糖。

处方 7 优降糖与氢氯噻嗪

优降糖 2.5mg×100 5mg qd po
氢氯噻嗪 25mg×100 25mg bid po

分析:用优降糖维持治疗的糖尿病患者,加用氢氯噻嗪后,可使血糖升高。此机制尚不完全清楚,有人认为噻嗪类利尿剂可抑制胰腺释放胰岛素;也有人认为是由低钾血症引起。现已证明,氢氯噻嗪对其他磺酰脲类降糖药(醋磺己脲、氯磺丙脲、甲苯磺丁脲等)也可发生此种影响。

处理方法:通过口服降糖药或胰岛素控制血糖的糖尿病患者,在开始用噻嗪类利尿剂后,应密切观察血糖浓度变化。停用利尿剂后,应观察有无低血糖症状。另外,也可通过增加口服降糖药的剂量,或用足量胰岛素代替口服降糖药,以控制血糖水平。

(全文完)

(201-03-15 收稿 2001-05-21 修回)

[于小雪 编发]

敬告读者

本刊从 2001 年第 10 期开始,改为大 16 开新版式,敬请各位读者阅后多提宝贵意见和建议,以便 2002 年正式改版时改进。请读者朋友相互转告。

欢迎投稿和订阅,邮发代号:2-48,国内统一刊号:CN11-3943,月刊 16 开本(2002 年改为国际通用大 16 开本),64 页,每期定价 6 元。全国各邮局均可订阅。若您漏订《中国临床医生》杂志,本编辑部也可以帮您邮购,但需加 15% 的邮费。

编辑部订购杂志电话:010-67617401。

人民卫生出版社《中国临床医生》编辑部